

Pappa

Innehåll

1. Det som redan fanns	2
2. Årskontrollen	4
3. Natttransporten	6
4. Att hålla trycket nere	7
5. Garaget	8
6. En centimeter	10
7. Graftet	12
8. Infarkterna	14
9. Hemåt, inte hem	16
10. Rutorna efteråt	17
11. Alla trådarna	19
12. Beslutet	20

1. Det som redan fanns

2013-2025 · Göteborg, Linköping och Öland

I journalen heter han Lars. För mig är han pappa.

När jag lägger de här pappren i tidsordning börjar historien inte den femte juni 2025. Den börjar långt tidigare, i en kropp som redan hade blivit undersökt, öppnad, lagad och övervakad. Journalen samlar allt i några rader. Högt blodtryck. Diabetes typ 2. Förmaksflimmer. Kronisk värk i ländryggen efter spinal stenosis. Ett hypofysadenom som inte producerade hormoner. Blodiga upphostningar. Andfåddhet.

År 2013 opererades pappa för ett aneurysm i bukaortan, en utvidgning av den stora kroppspulsådern. Läkarna förde in ett stentgraft genom blodkärlet och förstärkte aortan inifrån. Metoden förkortades EVAR. För oss andra blev förkortningen en del av hans bakgrund, något avslutat som ändå alltid fanns kvar när en ny läkare drog hans sjukdomshistoria.

Journalen minns kroppen. Kalendern minns annat. Där finns pappa som den som kom på fika, passade barnen och hjälpte till i familjens vardag. Sommaren 2015 står det först att han var på sjukhus, sedan att han skulle hämtas och några dagar senare att han skulle opereras. Kalendern säger inte för vad. Åren därefter återkommer han i korta rubriker: barnvakt, fika, semester, lunch, skjuts till Landvetter. En kväll 2016 skulle jag hjälpa honom att installera en dator. Det är inte stora händelser. Det är därför de betyder något här. De visar livet som pågick mellan diagnoserna.

Tio år senare utreddes han på Sahlgrenska för att han hade svårt att andas och hostade upp blod. Det fanns en misstanke om lungfibros. En bronkoskopi visade inga maligna celler och odlingarna var negativa för tuberkulos. Vad utredningen till slut landade i går inte att läsa ut av det material jag har. Det finns uppgifter om ett planerat återbesök, men ingen anteckning som sluter cirkeln.

Någonstans i den vevan flyttade pappa från Göteborg till Öland. Han bodde ensam och hade inga kommunala insatser.

År 2024 hade aneurysmet vuxit. Min kalender daterar nästa operation. Den tredje april skulle pappa skrivas in i Linköping. Jag hade en resa dit, besökstid och en hotellincheckning inlagda. Den fjärde står det **Pappa opereras**, senare **Pappa på Uppvak**, och på kvällen en resa hemåt.

Det gamla graftet förlängdes uppåt med ett fenestrerat graft, ett rör med öppningar anpassade efter de kärl som måste fortsätta få blod.

Efter operationen kände han sig svag i benen och föll på avdelningen. Fallet orsakade ett högersidigt subduralhematom, en blödning mellan hjärnan och den omgivande hinnan. Blödningen opererades. Journalen säger att varken CT eller MR visade någon ischemisk skada i hjärnan eller ryggmärgen. Den säger också att han behövde blodförtunnande för sitt förmaksflimmer och sin strokerisk, och att hematomet därför utrymdes subakut.

Jag berättade senare för vårdpersonalen att pappa hade varit akut förvirrad i samband med den operationen. Jag berättade också att hans minne gradvis hade blivit sämre under de senaste åren. Journalen gör två korta sakuppgifter av det. Resten - vilka samtal som upprepades, vad han glömde, när jag först började lägga märke till det - finns inte där ännu.

Efter hjärnblödningen hade dosen av hans blodförtunnande medicin sänkts. Pappa hade sedan själv minskat den ytterligare. Han tog en tablett om dagen i stället för två. Det var en av sakerna som kom fram när han gick till vårdcentralen för en läkemedelsgenomgång den femte juni 2025.

En annan sak var blodet.

Han hade hostat upp blod i flera år, men veckan före besöket hade det plötsligt blivit mycket mer. Andningen hade också blivit sämre. Han gick till hälsocentralen för en årskontroll och för att reda ut medicinerna.

Han kom inte hem därifrån.

2. Årskontrollen

5 juni 2025 · Borgholm och Kalmar

Besöket på Borgholms hälsocentral började klockan 14.27. Kontaktorsaken var skriven som läkemedelsgenomgång, årskontroll och dyspné.

Jag var inte i rummet. Det jag vet kommer från anteckningen.

Pappa och läkaren gick igenom medicinlistan. Han berättade att han hade minskat sin blodförtunnande medicin efter hjärnblödningen året innan. Han ville börja med Ozempic igen. Det fanns också oklarheter kring en kolesterolsänkande medicin som hade avslutats eftersom man oroat sig för att den kunde ha samband med den misstänkta lungfibrosen. Någon remiss från lungkliniken i Göteborg till lungkliniken i Kalmar tycktes inte ha kommit fram.

Sedan fanns de blodiga upphostningarna. Pappa sade att de hade pågått i tre år, men att mängden hade ökat plötsligt veckan före besöket och fortsatt på den nya nivån. Andfåddheten hade blivit värre. Till en början hade han ingen bröstsmärta.

Läkaren hörde biljud över lungorna. Ett EKG visade högersidigt skänkelblock. Det fanns inget äldre EKG att jämföra med. Fyndet diskuterades med hjärtintensiven eftersom ett nytillkommet skänkelblock, tillsammans med resten av bilden, kunde föra tankarna till en blodpropp i lungan.

Flera personer kopplades in: hjärtintensiv, lungkonsult och en kollega på hälsocentralen. Först var den samlade planen en snabb uppföljning på lungkliniken och en CT av bröstkorgen. Men när anamnesen gick igenom igen blev uppgifterna mer akuta.

Under besöket fick pappa svår smärta i bröstet och mellan skulderbladen. En senare anteckning anger tiden till omkring klockan fyra.

Efteråt berättade pappa för mig hur han själv mindes ögonblicket då smärtan kom. Läkaren hade knackat honom över bröstet och frågat: "Gör det här ont?" Pappa sade att det var då det brast. Han mindes hur läkaren ryggade tillbaka, med skräck i ögonen, och kastade sig på telefonen för att få dit en ambulans.

Det är pappas berättelse till mig. Journalen säger bara att den svåra smärtan kom under besöket.

Han skickades till akuten i Kalmar. Där visade CT något annat än den lungemboli man först hade behövt utesluta. Det hade uppstått en dissektion i aortan. Kärilväggens inre lager hade brustit så att blod trängde in mellan väggens lager. Dissektionen började vid vänster nyckelbensartär och fortsatte ned till graftet från operationen året innan.

De stora kärlen till bukens organ var inte engagerade. Det var en viktig uppgift, men den gjorde inte tillståndet mindre akut.

Pappa hade gått till vårdcentralen med en medicinlista, långvarig andfåddhet och blod som plötsligt hade blivit mer. Några timmar senare låg han på akuten med en ny skada i samma stora kroppspulsåder som redan hade opererats två gånger.

Nu skulle han till Linköping.

På kvällen ringde Lena, pappas syster. Läkarna hade bett henne kontakta mig, i stället för att de skulle behöva jaga rätt på mig. Det var så jag fick veta.

Jag började omedelbart ordna en resa till söndagen.

3. Natttransporten

Natten 5-6 juni 2025 · Kalmar-Linköping

Ambulansanteckningen är kort. Den redovisar klockslag, blodtryck, puls, syresättning och läkemedel. Den säger att pappa var vaken. Den säger att transporten gick utan anmärkning.

Bakom de orden finns en nattfärd tvärs över Småland och vidare till Universitetssjukhuset i Linköping.

I Kalmar hade pappa fått upprepade doser blodtryckssänkande läkemedel. Målet var att minska trycket mot den skadade aortaväggen. Han fick också morfin. Strax efter klockan två på natten låg blodtrycket på 130 över 72. Ambulansen fortsatte mot Linköping.

Klockan 02.45 kom han till hjärtintensiven. Då beskrevs han som välmående och stabil. Ambulanspersonalen hade just gett ytterligare morfin. Han kunde själv bekräfta historien om smärtan och undersökningen i Kalmar.

Läkarna kände redan till terrängen de arbetade i. Ett graft låg i bukaortan sedan 2013. År 2024 hade det förlängts med ett fenestrerat graft. Den nya dissektionen sträckte sig från vänster subclavia, kärlet som för blod mot vänster arm, hela vägen ned till den tidigare konstruktionen.

Det första beslutet var att inte operera.

Pappa skulle behandlas konservativt med smärtlindring och strikt blodtryckskontroll. En nitroinfusion startades. Han skulle ligga i sängen. Blodtrycket skulle till en början mätas fyra gånger i timmen och det systoliska trycket hållas under 120. En ny CT planerades till den sjunde juni.

Den blodförtunnande medicinen pausades. Metformin pausades efter kontrasten och inför nästa röntgen. Smärtläkemedlen utökades, liksom behandlingen mot den förstoppning opioiderna kunde orsaka.

I anteckningen betyder **stabil** att han var vaken, varm i armar och ben, utan tecken på att bukens organ hade förlorat sin blodförsörjning och med smärtan under kontroll. Det betyder inte att dissektionen hade försvunnit.

Det betyder att man kunde börja vänta.

4. Att hålla trycket nere

6-8 juni 2025 · HIA, Linköping

De första dygnen handlade om tryck.

Trycket i manschetten. Trycket mot den skadade kärlväggen. Trycket som måste vara lågt nog för att skydda aortan men högt nog för att resten av kroppen skulle fungera. Varje läkemedel och varje smärtgenombrott kunde flytta balansen.

Den sjunde juni var pappa tröttare och mattare. Andningen var tung och han hostade, men blev något bättre efter vätskedrivande läkemedel. Han låg kvar i sängen och tyckte att tryckavlastningsmadrassen var bra. Smärtan som hade fört honom till sjukhuset var då borta.

I slutet av anteckningen står att han väntade på att sonen skulle komma nästa dag och stanna i tre dagar. I samma kalendervecka finns både en tidigare helgbokning och de nya rutorna: Linköping, hotell, pappa.

Innan jag kom den åttonde försökte personalen få upp honom i en fåtölj med gåbord och hjälp av två personer. Benen bar nästan inte. När han väl satt i fåtöljen försökte han efter en kort stund ta sig tillbaka till sängen på egen hand. Han hade känt sig kissnödig och tänkt gå till toaletten, innan han kom på att han hade kateter. Han blev rädd av att benen inte bar och funderade över hur det skulle gå framåt.

Blodtrycket steg igen under kvällen. Han fick mer medicin. Han hade ont i bröstet och ryggen, först kraftigt, sedan avtagande. Han sade själv att han ibland blev snurrig i tanken.

Jag reste mot Linköping efter lunch den åttonde juni. Kalenderblocket går från 14.10 till 17.50. På Quality Hotel Ekoxen fanns en bokning från den åttonde till den elfte.

Jag kom till pappa på kvällen. Journalen noterar min ankomst, och att jag skulle vara med på rondan halv nio nästa morgon. Den säger att pappa gärna ville tala med en läkare.

Pappa kände igen mig, men han kunde inte mitt namn. Han blandade ihop mig med sin bror och sin andre son. Ändå var reaktionen tydlig. Han blev glad när jag kom och märkbart lättad.

Från och med den kvällen finns jag i materialet. Inte som huvudperson. Som sonen som väntar på rondan, ställer frågor och försöker förstå hur pappa både kunde känna igen mig och förväxla mig med två andra människor.

5. Garaget

9-11 juni 2025 · HIA och hjärtavdelning, Linköping

Natten till den nionde juni fick pappa ett sömnmedel. Vid tvåtiden mitt i natten vaknade han och ropade på hjälp. Han trodde att han hade blivit kidnappad och var instängd i ett garage.

Personalen satt hos honom och redde ut var han befann sig. Pappa frågade om det var något fel på hans hjärna. Han mådde dåligt över hur han hade betett sig och ville att dörren ut mot korridoren skulle stå öppen. Senare kunde han somna om.

På morgonen var jag med på rondan. Jag berättade att pappas minne gradvis hade blivit sämre under de senaste åren. Jag berättade om förvirringen efter operationen 2024, men också att det här var värre. Vissa stunder var han klar. Andra stunder var han mycket förvirrad. Han märkte det själv och var orolig.

Vid ett tillfälle började han hallucinera mitt framför mig. Han talade plötsligt osammanhängande om sådant som enligt honom hände i rummet, men som inte var verkligt.

Sömnmedlet togs bort och ersattes med ett preparat han tidigare hade tålt.

Samtidigt fortsatte kroppen att kräva sin bokföring. Urinen var knapp och koncentrerad. Han fick vätskedrivande och svarade på det. Det hördes rassel över lungorna. När han kom upp med gåbord och två personer var gången ostadig och han blev yr. Han åt med god aptit. Senare på kvällen, efter vila, var han klarare. Han fick en tandborste och tandkräm och borstade själv tänderna.

Så ser växlingarna ut i anteckningarna: hallucinationen i garaget, en rond där han själv förstod att tankarna inte fungerade, och några timmar senare en man som åt och borstade tänderna på egen hand.

Den tionde var han fortfarande trött men vid gott mod. Förstoppningen hade då varat i flera dagar trots behandling. Han fick mer laxermedel. Urinen var fortsatt knapp och koncentrerad, och han bedömdes vara uttorkad. Vätska sattes in inför en ny CT av aortan.

Sängen var för kort för honom. Han låg med fötterna mot gaveln, så personalen ordnade en förlängningsbar säng.

Jag var på avdelningen nästan hela dagen. Journalen berättar att jag gick tillbaka till hotellet på eftermiddagen när det var dags för röntgen och att jag kom tillbaka till middagen med mat så att vi kunde äta tillsammans. Kalendern ger hotellet ett namn, Quality Hotel Ekoxen. Vad vi åt och vad vi sade finns inte i någon av källorna.

Den elfte sade pappa att det hade varit bråk mellan patienter under natten. Att det var invandrare som hade slagits med kniv i korridoren. Personalen berättade att något sådant hade inte hänt. Jag sade till personalen att jag var orolig för hans kognitiva tillstånd. Senare samma dag berättade jag för läkaren att han varit förvirrad under hela vårdtiden, långsam i tanken och stundtals desorienterad. Under några timmar hade det blivit värre. Han hade hallucinerat och bland annat upplevt att telemetridåsan talade med honom. I korta episoder förändrades personligheten helt, han uttalade sig om personalen i vidriga termer, elaka föraktfulla och bittra ord jag inte kände igen hos min far.

Han hade samtidigt ont i bröstet och mellan skulderbladen på samma sätt som när dissektionen började. Smärtan skattades till sju av tio och svarade på oxikodon men inte på paracetamol. Inflammationsvärdet hade

stigit. Den nya CT:n visade att dissektionen hade samma utbredning som den femte juni men att diametern i den nedåtgående delen av bröstaortan hade ökat med upp till fyra millimeter.

Pappa flyttades tillbaka till hjärtintensiven för bättre blodtryckskontroll. Nitroinfusionen kopplades på igen. I kalendern ligger min hemresa mellan 16.25 och 20.10. Jag åkte tillbaka till Göteborg efter att ha varit hos honom från den åttonde till den elfte juni.

När jag lämnade Linköping var planen fortfarande att kontrollera trycket och följa aortan med nya bilder. Men aortan hade börjat växa.

6. En centimeter

11-16 juni 2025 · Linköping

Natten till den tolfte juni steg det systoliska blodtrycket över 170. Nitroinfusionen ökades. Pappa var förvirrad och visste inte var han befann sig.

Framåt morgonen låg trycket åter omkring 120. Senare kunde infusionen minskas och han flyttades till en vanlig hjärtavdelning. Där gick han med gåbord och två personer till toaletten. Benen var svaga. Under natten var han orolig och hade mardrömmar, men ryggsmärtan hade avtagit.

Orden i journalen växlar mellan **stabil** och **svårbehandlad**. Båda kunde vara sanna med några timmars mellanrum.

Den trettonde gick det inte längre att hålla blodtrycket nere med tabletter. Kardiologen ringde intensivvården och frågade om pappa kunde tas om hand där i stället. Ett kärlkirurgiskt ingrepp planerades preliminärt till nästa dag, men det material som behövdes fanns ännu inte på plats. Man försökte ordna fram det. Samtidigt skulle en intensivvårdsenhet stänga och antalet platser på thoraxintensiven minskas.

I en enda anteckning finns därför både den medicinska brådskan och sjukhusets logistik: aortan behövde kanske behandlas under helgen, ett särskilt graft måste finnas, narkos och intensivvård krävdes, och platserna var få.

Samtidigt skulle min svärfar fira sin sjuttioårsdag i Årdala. Det var inget jag kunde undvika. Familjen släppte av mig i Linköping på vägen dit. I kalendern ligger en hotellbokning från den trettonde till den femtonde.

Den fjortonde placerar journalen mig på avdelningen igen. Pappa hade flyttats till thorax uppvaknings- och intensivvård, men planen var att han skulle tillbaka till hjärtintensiven om han förblev stabil och stentbehandlingen kunde vänta. Jag var välinformerad och bad att bli kontaktad om hans tillstånd förändrades eller om det blev operation.

Samma dag tog jag mig vidare med tåg till Flen för att kunna vara med på kalaset.

Balansakten hade blivit ännu svårare. När det systoliska trycket pressades under 110, som man önskade för aortans skull, blev medeltrycket lågt. Då minskade urinproduktionen och kreatinin steg, tecken på att njurarna inte fick vad de behövde. Han fick vätska och en liten dos vätskedrivande samtidigt. Hjärtat gick i långsamt förmaksflimmer. Andningen var något ansträngd och under sömn hade han andningsuppehåll.

Ändå satt och stod han med hjälp. Den dagen var han orienterad, lugn och hade inga hallucinationer.

Efter lunch kom han tillbaka till hjärtintensiven, mycket trött och sovande tungt. En infusion med blodtryckssänkande läkemedel pågick. I planeringen stod möjlig operation måndagen den sextonde.

När vårdtiden senare sammanfattades hade den nedåtgående aortan inte bara ökat med de fyra millimeter som syntes på kontrollen den tionde. Den samlade bedömningen var nu en diameterökning på ungefär en centimeter under åtta eller nio dagar. Aortan mätte mer än fem centimeter, och det fanns en vätskereaktion runt den.

Det förändrade beslutet.

På morgonen den sextonde avslutades pappas första vårdperiod på hjärtkliniken. Han togs över av kärlkirurgerna. Det som först skulle behandlas med sängläge, smärtlindring och ett systoliskt tryck under 120 skulle nu opereras akut.

Väntan var över.

7. Graftet

16 juni 2025 · Kärlkirurgin, Linköping

Jag stod inte i operationssalen. Det här kapitlet har jag dels från operationsberättelsen, dels från det jag själv minns av väntan på avstånd.

Jag ville åka till pappa, men läkarna kunde inte säga när operationen skulle bli av. De sade att det inte var någon idé att jag åkte upp. Ingreppet sköts fram dag för dag och det gick inte att planera en resa.

En del av förklaringen till uppskjutningarna fanns i själva graftet. Linköping hade inte det som behövdes. Sådana graft tillverkades, som jag fick det berättat för mig, i Australien. Vården fick ringa runt och hittade till slut ett överblivet graft i Stockholm. Det skickades till Linköping för att laserskäras och anpassas till pappas aorta.

Det var ännu en kedja av saker som behövde falla på plats innan operationen kunde börja. Att läget inte hann bli ännu mer akut innan allt var klart känns i efterhand som en stor portion tur.

Sedan ringde en läkare för att förbereda mig. Jag minns beskedet som att detta var en mycket svår operation: femtio procents risk att pappa skulle dö, stor sannolikhet för förlamning i hela vänster sida och stor risk att han skulle behöva stomi resten av livet.

Pappa hade tidigare sagt att om han hamnade i en sådan situation och jag blev tillfrågad, ville han inte vakna. Det var de orden jag bar med mig in i operationsdagen.

Jag var hemma när läkaren ringde. Efteråt ringde jag Lena. Vi försökte ta in beskedet tillsammans.

I kalendern är måndagen ett block från elva till sex med rubriken **Pappa opereras**. Runt omkring ligger mina egna arbetsblock. Själva ingreppet finns nedskrivet steg för steg.

Kirurgerna skulle lägga ett nytt stentgraft i bröstaortan och över aortabågen. Problemet var att tre stora kärl lämnar bågen och för blod till huvudet och armarna. Ett vanligt tätt graft kunde inte bara täcka deras öppningar.

Ett graft demonterades och modifierades med laser. Tre fenestrationer gjordes: en för arm-huvudstammen, en för vänster halsartär och en för vänster nyckelbensartär. Öppningarna för de två vänstra kärlen förstärktes. Graftet sattes sedan ihop igen och förbereddes för att föras in i kroppen.

Pappa sövdes.

Operatörerna skapade tillträde genom kärl i höger ljumske, vänster ljumske, vänster arm och vänster hals. En kabel för snabb hjärtstimulering fördes till höger kammare. Själva graftet gick in genom vänster ljumske och upp genom aortan.

Införingssystemet var för kort. Det nådde inte runt till aortabågen på det sätt man behövde. Graftet hamnade först för långt ned.

Operationsberättelsen ändrar inte ton när detta händer. Den fortsätter steg för steg. Vänster subclavia kanylerades. Ballonger fördes genom öppningarna för halsartären och nyckelbensartären. Med hjälp av dem kunde kirurgerna dra graftet till rätt plats. Öppningarna vidgades och fick egna stentgraft. Konstruktionen förlängdes sedan nedåt i bröstaortan med ytterligare ett graft.

Allt detta skedde inuti de kärl som redan bar spår av operationerna 2013 och 2024, medan hjärtat vid avgörande moment drevs i snabb rytm.

Den sista kärlröntgen visade inget fel. Insticksställena slöts eller komprimerades. Diagnos- och åtgärdsraderna räknade upp en typ B-dissektion, ett stent i aorta descendens, ett stentgraft i vänster subclavia och ett i vänster carotis communis.

I den senare slutanteckningen kallades operationen lyckad.

Aortan var lagad. Nu återstod att se vad ingreppet och de föregående elva dyggen hade gjort med resten av pappa.

8. Infarkterna

17-18 juni 2025 · Thoraxintensiven, Linköping

Efter operationen började jag på nytt försöka planera för att komma till pappa. Läkarna avrådde mig från att åka. De kunde inte säga när han skulle vakna eller när han skulle vara tillräckligt klar i huvudet för att jag skulle kunna nå honom.

Det var samma konflikt igen: att inte komma för tidigt, men inte heller för sent.

Efter operationen väcktes pappa och andningstuben togs bort. Han var förvirrad och motoriskt orolig. Han fick lugnande läkemedel och Haldol för att dämpa tillståndet.

En CT av hjärnan den sjuttonde juni visade nytillkomna infarkter.

Journalerna är inte helt eniga om deras exakta läge. En slutanteckning från Linköping beskriver en misstänkt färsk infarkt i vänster hjässlob och en misstänkt infarkt i höger lillhjärna. Anteckningen i Kalmar följande morgon beskriver infarkter i nacklob och vänster hjässlob. De är eniga om det avgörande: efter operationen fanns nya strokeskador och ödem som kunde förklara medvetandepåverkan.

Samma dag ringde min syster. Hon fick inte tag på mamma, som också var sjuklig. Jag avfärdade det först.

Mamma brukade ibland inte svara därför att hon låg och sov. Det hände titt som tätt. Jag trodde att det var samma sak nu.

Några timmar senare ringde min moster. De brukade tala med varandra varje dag. Nu hade hon inte hört av mamma på tre dagar.

I kalendern heter de följande två timmarna **Mamma intervention**.

Jag höll på att förbereda mig för att åka till pappa men fick åka till mamma i stället. Dörren var olåst. Hon låg halvt okontaktbar på sängen.

Hon hade blivit magsjuk, kräkts och haft diarré. Hon var så svag att hon inte hade kunnat ta sig till datorn. Synen hade blivit så dålig att hon fumlat med mobilen, låst den och inte kunde använda den.

Mamma vägrade låta mig ringa ambulans. Jag stannade och fick henne att dricka buljong.

Morgonen därpå står det **Ringa Äldrevård** i kalendern. Det var inte en allmän påminnelse och det gällde inte pappa. Det var nästa steg i att ordna hjälp åt mamma. Mitt i pappas strokevård hade jag fått börja organisera omsorg för min andra förälder också.

Sent på kvällen den sjuttonde fick Lena, pappas syster, ett läkarsamtal. Hon informerades om CT-fyndet, förvirringen och den påverkade medvetandegraden. Blodtrycket fortsatte att svänga kraftigt, och vården försökte samtidigt hålla det systoliska trycket omkring 130 och medeltrycket över 80.

Efteråt ringde hon mig. Hon var helt förtvivlad.

Den artonde var pappa mer vaken. Han kunde uppge sitt personnummer och svara när personalen talade med honom. Han kunde föra ett samtal med sin syster och med mig i telefon.

Att vi talade står i journalen. Men jag minns inte samtalet som sammanhängande. Pappa visste inte var han var eller vem jag var. Han kom inte ihåg vilket år det var, sin bror, sin andra son eller ens var i Sverige han själv bodde.

Efteråt var jag helt förstörd. Jag var rädd att pappa hade blivit vad jag då tänkte på som en grönsak, och att det skulle vara så för alltid.

Han var fortfarande inte orienterad till vad som hade hänt eller till var han befann sig. Den motoriska oron fortsatte och han kunde inte riktigt styra den. I en senare anteckning sade han själv att han hallucinerade. Lugnande infusion pågick i låg dos och han fick ytterligare Haldol.

Han rörde båda armarna och båda benen. Två gånger satt han på sängkanten i ungefär en halvtimme. Personalen försökte hjälpa honom att stå, men han hade inte kraft nog att resa sig. Senare satt han i en mobiliseringsstol en halvtimme och ytterligare en stund på kvällen.

Han behövde tre till fem liter syrgas. Blodtrycket fortsatte att växla mellan ungefär 110 och 160. Njurfunktionen hade försämrats men började återhämta sig, och urinproduktionen hölls igång med vätskedrivande infusion. En urinodling visade bakterieväxt och antibiotika sattes in, bland annat eftersom han nu hade så mycket stentmaterial i kroppen.

Han åt lite yoghurt och tog tabletter, men blev illamående efteråt. Han hade inte skött magen under tiden på thoraxintensiven. För att sitta upp behövde han hjälp av tre personer.

Operationen hade förseglat dissektionen. Ändå var pappa fortfarande inte tillbaka från den.

9. Hemåt, inte hem

Natten 18-19 juni 2025 · Linköping-Kalmar

På kvällen den artonde juni förbereddes pappa för att lämna Linköping.

Han var ibland adekvat, ibland hallucinerande och motoriskt orolig. Han rörde armar och ben liksidigt. Han sade att han inte hade ont. Förmaksflimret låg mest mellan sextio och nittio slag i minuten, men pulsen kunde bli långsam under den lugnande infusionen. Händerna var varma och fötterna kalla.

Han hade kateter, en central infart i halsen och en perifer infart i handen. Insticksstället i höger ljumske såg bra ut. I vänster ljumske fanns ett stygn som skulle tas senare. Han behövde syrgas men hade svårt att tolerera mask, högflöde och andningsstöd. Han hade fått i sig lite yoghurt och äppeldricka. Resten av näringen och vätskan gick genom infusioner.

Planen var att föra honom till intensivvården i Kalmar. Transporten skedde nattetid när en ambulansresurs fanns tillgänglig. Det administrativa vårdtillfället i Linköping slutade klockan 01.30 den nittonde juni.

Färden gick i riktning mot Öland och det som hade blivit hans hem, men han var inte på väg hem. Han var på väg från en intensivvårdsavdelning till en annan.

Klockan 05.04 skrevs den första anteckningen i Kalmar. Den samlade de senaste två veckorna i komprimerad form: dissektionen den femte juni, den fenestrerade stentoperationen den sextonde, förvirringen efteråt och infarkterna på CT den sjuttonde.

Pappa svarade på tilltal och rörde alla extremiteter. Han hade kunnat sitta upp. Han behövde fortfarande syrgas. Blodtrycket varierade och pulsen var långsam. Njurfunktionen var akut försämrad men kreatinin sjönk. Han behandlades med antibiotika efter bakteriefyndet i urinen. Han hade ont i ryggen och fick gabapentin och morfin.

Läkaren bedömde att infarkterna och svullnaden runt dem förklarade medvetandepåverkan, och att den tycktes gå långsamt tillbaka. Planen var uppföljning av neurolog. Bilderna hade också visat tecken på interstitiell lungsjukdom som skulle följas upp på hemsjukhuset.

På papperet var operationen i Linköping avslutad. I Kalmar började arbetet med allt som fanns kvar efter den: medvetandet, syret, njurarna, infarkterna och en kropp som ännu inte bar honom.

Ambulansen hade fört honom söderut, närmare huset på Öland. Men inte en enda rad i morgonens plan handlade om att han skulle hem.

10. Rutorna efteråt

24 juni-början av juli 2025 · Kalmar och Åkerbohemmet

Fem dagar senare reste jag mot Kalmar. Kalendern lägger färden mellan kvart i åtta på morgonen och tolv. Sedan står det HIA Kalmar, från tolv till halv fyra.

På vägen upp körde jag som ett jehu för att komma till sjukhuset. Ett rejält stenskott slog in i vindrutan.

Vid den här tiden började jag varje samtal med pappa på samma sätt. Vilket år var det? Vem var jag? Visste han vad som hade hänt?

Jag ställde frågorna för att försöka förstå om han hade blivit bättre. Sedan förklarade jag hela förloppet igen. Varför han var på sjukhus. Vad som hade hänt i Linköping. Att han hade opererats och fått stroke.

Pappa var orolig. Han kunde inte minnas varför han var där. Han kom ihåg att han hade suttit hos läkaren i Borgholm, men tiden därefter var borta. För mig verkade det som om stroken hade tagit hela perioden ifrån honom och nu hindrade förklaringarna från att stanna kvar som nya minnen.

Nästa gång började vi om med samma frågor.

När jag kom ut från sjukhuset satt en fem centimeter lång metallskärva i ett av däcken.

Jag lyckades få dit en bärgningsbil. Det gick inte att laga däck permanent på plats, men bärgaren fick till en provisorisk lagning. Sedan kunde jag halta hem med bilen.

I kalendern ryms allt detta i ett enda ord: **Punka**. Hemreseblocket mot Göteborg börjar klockan fem och slutar vid elva.

Två dagar senare antecknade jag ett långt samtal med en överläkare på strokeavdelningen. Enligt det jag skrev ned sade hon att pappa hade fått tre akuta strokeinfarkter, inte två, på båda sidor av hjärnan.

Det här är inte en ny journalanteckning. Det är mitt referat av vad läkaren sade till mig.

Skadorna gjorde det svårt för pappa att ta till sig träning och komma ihåg säkerhetsinstruktioner. Han såg dubbelt, och läkaren knöt enligt min anteckning synproblemet till en av infarkterna. Det var ännu oklart hur hans förmåga att läsa och räkna hade påverkats. Om han föll kunde följderna bli mycket allvarliga, samtidigt som hans minne gjorde säker rehabilitering svår.

Läkaren var tydlig: pappa skulle inte kunna återvända till ett hem utan tillsyn. Han kunde inte forma nya minnen på det sätt som krävdes för att klara mediciner, förflyttningar och risker. Läget var skört, även om det inte just då beskrevs som direkt akut.

Hon föreslog att vi skulle göra ett fotoalbum med ansikten och namn. Något pappa kunde bläddra i tillsammans med personalen och tala om även när det nya inte stannade kvar.

Följande dag kom ett annat besked genom familjen. Pappa skulle få en korttidsplats på måndagen. Samtidigt fanns uppfattningen att han sedan skulle kunna komma hem. Något gemensamt vårdssamtal med oss anhöriga hade inte hållits.

På ena sidan: han kunde inte återvända till ett hem utan tillsyn. På den andra: korttidsplats och sedan kanske hem.

Jag ringde tillbaka till läkaren och bad henne kontakta mig. I en senare rad står att korttidsplatsen skrevs fram och att pappa fick den.

I början av juli kom pappa till Åkerbohemmet på en korttidsplats. Den var beviljad för två veckor.

Det löste den omedelbara frågan. Han skulle inte skickas hem direkt från strokeavdelningen. Men korttidsplatsen gav inget svar på vad som skulle hända när de två veckorna var slut.

11. Alla trådarna

Juli 2025 · Göteborg, Öland och telefonköerna däremellan

När pappa inte längre kunde hålla ihop alla sina ärenden själv upphörde inte ärendena.

Räkningarna fortsatte att komma. Autogiron fortsatte att dras. Bilen hade försäkring och verkstad. Telefonen hade abonnemang. Apoteket behövde kunna ta betalt. Banken behövde veta vem som fick göra vad. Myndigheterna hade en adress, den digitala brevlådan en inloggning och varje företag sin egen bild av vad en giltig fullmakt var.

I mina anteckningar blir pappa en lista.

Original till kopia av fullmakt. BankID. Två konton, ett för kortet. Adressändring. Digital myndighetspost. Apotekskonto. Boendekostnad. Försäkring. Fakturor som skulle tas bort. Abonnemang som skulle avslutas. Bilen som stod kvar i en annan del av hans liv.

Varje rad ledde till en ny människa som behövde få samma historia. Pappa hade opererats. Pappa hade fått stroke. Pappa kunde inte själv legitimera sig, minnas instruktionen eller ringa nästa nummer. Jag behövde ändå bevisa att jag hade rätt att hjälpa honom.

Anteckningarna är fulla av telefonnummer, namn och belopp. De hör inte hemma i berättelsen. Det som hör hemma här är rörelsen mellan dem: banken behövde en fullmakt, fullmakten behövde nå ett kontor, adressen behövde ändras, en faktura behövde stoppas och nästa handläggare behövde höra allt från början.

Samtidigt bodde pappa tillfälligt på Åkerbohemmet. Under korttidsveckorna fortsatte räkningarna, fullmakterna och samtalen, samtidigt som nästa beslut närmade sig.

Korttidsplatsen hade löst utskrivningen från sjukhuset. Nu behövde vi lösa vad som skulle komma efter den.

12. Beslutet

16 juli 2025 · Åkerbohemmet

Den sextonde juli, när korttidsperioden närmade sig sitt slut, fanns en timme i kalendern med rubriken **Möte pappa åkerbohemmet**.

Det var ett tufft samtal. Som situationen förklarades för mig behövde pappa själv samtycka till att bo kvar. Samtidigt förstod han inte hur sjuk han var eller varför han inte kunde återvända hem.

Sjuksköterskorna, läkarna, pappas syster Lena och framför allt jag försökte få honom att förstå läget och acceptera att han behövde bo där. Jag använde ett mycket tydligt språk mot pappa.

Efteråt sade en sjuksköterska till mig: "Det måste ha varit tufft att säga så till sin far. Men det var rätt och nödvändigt."

Vårdsamtalet slutade med ett beslut.

Pappa skulle få långtidsboende.